Autos: 0800481-37.2022.8.12.0037
Ação: Procedimento Comum Cível - Fornecimento de medicamentos
Requerente:Enrico Imai Burlim
Réu: Unimed de Dourados Cooperativa Trabalho Médico

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ajuizada por **Enrico Imai Burlim** em face de **Unimed de Dourados Cooperativa Trabalho Médico**.

Em síntese, sustenta a parte autora que possui 3 (três) anos de idade, sendo que é dependente do plano de saúde da requerida através de sua genitora, pelo n. de cartão 0 078 006600077711 5.

Afirma que *"fora diagnosticado com Diabetes tipo I ou insulino-dependente (CID- 10:E10.9) desde a data de 01/03/2022, aos 3 anos e 3 meses. Ademais, assevera que também foi diagnosticado com cetoacidose diabética leve em 01/03/2022, tendo sido internado para estabilização e ajuste de doses de insulina por 03 dias, e, desde então encontra-se em acompanhamento."*

Declara que *"Após algum tempo, o reclamante recebeu alta hospitalar usando insulina glargina (Lantus) e insulina FIASP (fast Aspart) para correção das glicemias, porem devido a hipoglicemias recorrentes, foi necessário mudar a insulina basal para degludeca (Tresiba) na data de 29/03/2022."*

Juntou aos autos laudo médico que *"relata que o requerente apresenta oscilações glicêmicas frequentes, necessitando de doses de insulina muito baixas, que só poderiam ser conseguidas através de um equipamento com sistema de infusão contínua de insulina." (fls. 38-40).*

Narra que *"Por se tratar de uma CRIANÇA DE 03 ANOS DE IDADE, que atualmente está matriculado em uma escola, necessita de um suporte de segurança para hipoglicemia como o sistema 780 G, que permite suspensão da infusão de insulina antes de apresentar hipoglicemias."*.

À fl. 37 consta os medicamentos e insumos receitados, os quais tiveram o fornecimento indeferido pela requerida, uma vez que, segundo ela, o procedimento não está abarcado pela RN 465/2021, anexo I da ANS e Lei 9659/98.

Em complementação, afirma a parte autora que *"DEVIDO O NÃO FORNECIMENTO DA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA, O MENOR ESTÁ SENDO SUBMETIDO A UM TRATAMENTO QUE NÃO RESOLVE O SEU PROBLEMA DE SAÚDE, TENDO QUE SE SUJEITAR A APROXIMADAMENTE 20 DOLOROSAS AGULHADAS POR DIA."*.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 20/09/2023 às 18:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800481-37.2022.8.12.0037 e código zl1cb4vl.

Pedido liminar deferido às fls. 67/70.

Impossibilidade de cumprimento da liminar noticiada às fls. 152/154, com despacho à fl. 171.

Conciliação infrutífera (fl. 228).

Decisão visando dar seguimento ao feito às fls. 238/239.

Contestação às fls. 240/255.

Juntada de agravo de instrumento revogando a liminar (fls. 269/276).

Impugnação à contestação às fls. 295/306.

Esclarecimentos sobre o trâmite processual às fls. 338/339.

Pedido de julgamento antecipado do feito pela parte autora (fl. 350).

Decisão deferindo pedido de parcelamento do ressarcimento devido pela parte autora às fls. 354.

Manifestação da parte requerida quanto à produção de provas às fls. 363.

Deferimento de expedição de alvarás de levantamento em favor da requerida (fls. 368).

Manifestação da parte autora quanto à documentação juntada pela requerida (fls. 543/547).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Cabível o julgamento do feito nos termos do artigo 355, I, do CP.

Passo à análise das preliminares.

Rejeito a impugnação à justiça gratuita, haja vista que, na avaliação de gratuidade de justiça, se apura a condição econômica da parte, no caso o

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 20/09/2023 às 18:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800481-37.2022.8.12.0037 e código zl1cb4vl.

menor, e não de seus representantes legais.[1]

Inexistindo outras preliminares ou questões processuais pendentes, passo, súbito, à análise do **MÉRITO**.

Inicialmente, é importante reforçar que **há relação jurídica de consumo** nos planos de saúde, pois o consumidor é o titular de planos de saúde, seus dependentes, os agregados, os beneficiários, os usuários, ou seja, todos os que utilizam ou adquirem planos de saúde como destinatários finais ou equiparados.

Nesse sentido, prevê a Lei 9.656/98:

> *Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade* ***e, simultaneamente, das disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),*** *adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:*

Feita tal ponderação, ressalto que **a controvérsia jurídica da presente demanda** gira em torno de o tratamento pleiteado pelo autor estar, ou não, acobertado pelo plano de saúde contratado junto à empresa requerida.

Sobre a controvérsia, narra a requerida que (fl. 243):

> Ou seja, um equipamento utilizado para a aplicação e controle do medicamento de uso contínuo (insulina).
>
> O equipamento trata **de uma órtese externa**, que tem como função auxiliar funções de órgãos do Requerente, e não está ligada a qualquer ato cirúrgico.
>
> Assim, trata-se de material permanente ou transitório que **auxiliam as funções de um membro, órgão ou tecido** (art. 4º, VI, RN nº 465/2021) e não se confunde com a prótese, pois, estas substituem total ou parcialmente um membro, órgão ou tecido (art. 4º, V, RN nº 465/2021).
>
> A Requerida só tem o dever de fornecer órteses ligadas ao ato cirúrgico, **sendo expressamente excluída a cobertura de qualquer material fora da hipótese legal**:

Acrescenta que *o Rol da ANS dispõe pela previsão de cobertura de órteses apenas quando ligadas ao ato cirúrgico (art. 17, VII e 19, VI, Resolução 465/2021 da ANS), o que não é o caso dos autos (fl. 243).*

Nesse cenário, alega a parte requerida que *como o Requerente pleiteou órteses não ligadas ao ato cirúrgico, é indevido o fornecimento do material*

[1] AREsp 2.019.757 - STJ

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 20/09/2023 às 18:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800481-37.2022.8.12.0037 e código zl1cb4vl.

pleiteado (fl. 244).

Afirma, também, que *O contrato é expresso ao excluir de suas coberturas obrigatórias o fornecimento de órteses não ligadas ao ato cirúrgico (fls.194).*

Já no que toca ao medicamento e os insumos de uso domiciliar, aponta que esta cobertura também está excluída no contrato (fl. 193), exclusão esta que *está devidamente autorizada pela Lei 9.656/98 (art. 10, VI) e pela RN 465/2021 (art. 17, VI).*

Por fim, salientou que o rol da ANS é taxativo nos termos da jurisprudência do STJ aliada aos critérios da Lei 14.454/22 (fl. 248).

Ao seu turno, em resumo, aponta a parte autora que a excepcionalidade exigida pela Lei 14.454/22 está presente no caso em debate, motivo pelo qual a pretensão deveria ser concedida.

Expostos os argumentos das partes, passo à fundamentação concreta.

Conforme consta na inicial e nos documentos juntados, é nítido que **a doença crônica que afeta o autor está entre aquelas patologias listadas como de cobertura obrigatória** de tratamento na esteira do artigo 10, da Lei nº. 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde).

Por outro lado, o artigo 2º da Resolução 465/2021, da ANS, afirma ser taxativo *o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta RN e seus anexos.*

Nesse sentido, o STJ, **após** o ajuizamento da presente ação, alterou seu entendimento ao estabelecer que:

> *1 - **O rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;***
> *2 - **A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;***
> *3 - É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;*
> *4 - **Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 20/09/2023 às 18:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800481-37.2022.8.12.0037 e código zl1cb4vl.

> *(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da Saúde Suplementar;*
> *(ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;*
> *(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e*
> *(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.*
> ***STJ. 2ª Seção. EREsp 1.886.929-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/06/2022 (Info 740).***

Na sequência, não se pode deixar de registrar que sobreveio a lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022 alterou a Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998), especificamente no parágrafo primeiro do art 1º:

> *§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que* ***não estejam previstos no rol referido no § 12 (rol da ANS)*** *deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:*
>
> ***I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; OU***
>
> *II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR)*

Ao que se colhe, **a lei em questão**, posterior ao mencionado precedente do Superior Tribunal de Justiça, **afastou a natureza taxativa ao Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar**, impondo a cobertura pelos planos de saúde dos tratamentos ou procedimentos não listados, desde que presentes os critérios previstos nos retrotranscritos incisos I e II do § 13.

No caso em apreço, o autor logrou êxito em demonstrar que, apesar de o tratamento vindicado não estar no rol da ANS, há eficácia na técnica pleiteada à luz das ciências da saúde através de evidências científicas, conforme se depreende dos documentos juntados às fls. 37/40 e 548/552:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 20/09/2023 às 18:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800481-37.2022.8.12.0037 e código zl1cb4vl.

paciente.

Segue abaixo os principais trechos do documento "Diretrizes para o Tratamento de Diabetes Mellitus 2019/2020", da Sociedade Brasileira de Diabetes, esclarecendo a equipe os principais pontos sobre esse tipo de terapia.

Bomba de infusão de insulina

A bomba de insulina é um sistema de infusão contínua (SIC) subcutânea de insulina que foi desenvolvida e teve seu uso difundido nos Estados Unidos a partir de 1970. No Brasil, chegou há cerca de 20 anos e está sendo cada vez mais conhecida e prescrita. O objetivo da terapêutica com o SIC de insulina, mais comumente chamado de bomba de infusão de insulina, é simular ao que ocorre no organismo da pessoa sem diabetes, mantendo a liberação de insulina durante 24 horas para tentar obter níveis normais de glicose entre as refeições e liberar insulina nos horários de alimentação. Assim, diversos fatores têm contribuído para o aumento do seu uso, incluindo o foco nos desfechos favoráveis da terapia insulínica intensiva, preferências do paciente, tecnologias cada vez mais confiáveis, além de observação da redução do risco de hipoglicemias graves com o sistema. A bomba de infusão de insulina convencional é um dispositivo mecânico com comando eletrônico, do tamanho de um pager, pesando cerca de 80 a 100 g. Conta com um reservatório de insulina e um cateter pelo qual ocorre a infusão da substância no tecido subcutâneo do paciente. É colocada externamente ao corpo, presa na cintura ou pendurada por dentro da roupa com o auxílio de estojos, clipes ou suportes, e deve ser usada ao longo das 24 horas do dia. Pode ser retirada em situações excepcionais por no máximo 2 horas.[20,21] Com esse sistema, em vez de receberem múltiplas doses de injeções subcutâneas de insulina de curta a longa duração, os pacientes passam a receber uma infusão subcutânea contínua de análogos ultrarrápidos em forma de microdoses basais ao longo do dia, de acordo com a dosagem previamente definida pelo médico, e bolus antes das refeições.1 90 Uso de tecnologia para melhor gerenciamento da glicemia Para o cálculo de bolus de insulina, as bombas possuem softwares incorporados ao seu sistema, auxiliando o paciente nesse processo. O médico programa a razão insulina:carboidrato e o fator de sensibilidade do paciente, e, com base nessas informações associadas ao valor de glicemia capilar, o software calcula a dose de bolus recomendada. Tal mecanismo de cálculo ajuda o paciente, simplificando a rotina de autocuidado, extremamente necessária aos usuários de bomba de insulina. É importante lembrar que cabe ao paciente informar à bomba sua glicemia capilar e quantidade de carboidratos ingeridos a partir da "contagem de carboidratos", para que a bomba apenas auxilie no cálculo, devendo o paciente confirmar e solicitar a liberação da administração dessa insulina em bolus. Além disso, ele pode escolher diferentes tipos de bolus, que vão alterar a forma de entrega da insulina calculada de acordo com o tipo de composição nutricional da refeição realizada. O bolus estendido, quadrado ou prolongado, possui duração mais extensa, sendo usado, por exemplo, em churrascos. Outra opção disponível é o bolus duplo ou multionda, no qual a administração da insulina é dividida em duas partes: uma imediata e outra estendida ao longo de algumas horas. Outro aspecto importante na bomba de insulina é que, ao calcular a dose de bolus, o software da bomba considera a quantidade de insulina ativa restante de bolus anteriores, subtraindo seu valor da dose atual recomendada. Dessa forma, diminui a possibilidade de sobreposição de doses e consequente hipoglicemia. Todas essas características positivas bombas facilitam o manejo do diabetes. Alguns dos atuais sistemas de infusão de insulina possuem também uma comunicação com os sensores de monitoramento contínuo de glicose, mostrando, dessa forma, tendências de glicemia e atuando na suspensão de insulina com a hipoglicemia ou sua previsibilidade (descrito adiante).

Terapia insulínica em sistemas de infusão continua de insulina

(...) Em crianças, a hipoglicemia geralmente é um fator limitante para o tratamento intensivo e o bom controle do DM (B, A).[19,20] Alternativamente, pode-se instituir o tratamento intensivo com o uso de bombas de infusão de insulina, no qual a única insulina utilizada é a ultrarrápida (lispro, asparte ou glulisina). Constitui-se no mais fisiológico meio de administração de insulina no sistema basal-bolus e que mais proximamente simula o padrão de secreção de insulina pela ilhota pancreática, além de possibilitar maior flexibilidade na administração de insulina e reduzir a variabilidade glicêmica quando corretamente utilizada. Tem se mostrado eficiente em crianças pré-escolares, escolares e adolescentes; em crianças de 1 a 6 anos, melhorou a qualidade de vida e mostrou-se factível e segura, levando os autores a considerarem essa modalidade terapêutica opcional para esse grupo de pacientes (B).21 Já em pacientes de mais idade, incluindo-se os adolescentes, o uso de sistema de infusão contínua de insulina (SICI) fez melhorarem os controles glicêmicos, reduziu a frequência de hipoglicemias e aumentou a qualidade de vida (B)[22] Recentes avanços no tratamento com SICI utilizando monitorização glicêmica com sensor de glicose (CGMS – continuous glucose monitoring system) tem comprovada eficácia em alcançar os alvos glicêmicos, sobretudo antes das refeições, em combinação a uma redução de hipoglicemias, uma das principais barreiras em atingir o bom controle metabólico em crianças e adolescentes. Um consenso recente realizado pela European Society of Pediatric Endocrinology, Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society e ISPAD, endossado pela American Diabetes Association e European Foundation for the Study of Diabetes, traz o resumo e as principais indicações do uso de SICI no paciente pediátrico (A).[23]

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 20/09/2023 às 18:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800481-37.2022.8.12.0037 e código zl1cb4vl.

Tecnologia com bomba de infusão de insulina

A terapia com bomba de insulina vem sendo utilizada no mundo desde o final da década de 70. No Brasil, essa tecnologia chegou no início do século XX e o número de pessoas utilizando a terapia vem crescendo. Segundo a American Association of Diabetes Educators(2018) existem mais de 1.000.000 de pessoas com diabetes em terapia com bomba de insulina em todo o mundo. Nos EUA, estima-se que existam entre 350.000-515.000 pessoas e no Brasil não existem dados estatísticos atualizados.

Geralmente essa terapia é utilizada para pessoas com Diabetes tipo 1, mas também pode ser utilizada para Diabetes tipo 2, em insulinoterapia. No Brasil existem bombas com calculadoras inteligentes e sistemas integrados de bomba com Monitorização Contínua de Glicose, que suspendem a infusão de insulina na hipoglicemia ou na previsão da hipoglicemia.

A Bomba de Infusão (BI) é um dispositivo eletrônico, parecido com os antigos bips, que fica conectada ao corpo através de um cateter, ligado à um reservatório com insulina, e uma cânula flexível inserida no tecido subcutâneo. A orientação é que todo o conjunto de infusão seja trocado a cada 48 a 72 horas, para evitar inflamação ou infecção local. Os locais que podem ser utilizados para aplicação são os mesmos da injeção: abdome, braços, coxas, flancos e glúteos.

O tipo de insulina usado na BI é a insulina análoga de ação ultra- rápida. Sua infusão é feita em micro doses, simulando o funcionamento fisiológico do pâncreas através da infusão de insulina basal e bolus. A insulina basal é a quantidade de insulina administrada durante às 24 horas e a insulina bolus é a quantidade de insulina administrada para correção da glicemia (hiperglicemia) e para as refeições, utilizando a técnica de contagem de carboidratos. Isso aumenta a flexibilidade no estilo de vida e melhora do controle glicêmico.

As calculadoras inteligentes são configuradas individualmente com os seguintes parâmetros: relação insulina/carboidrato, fator de sensibilidade, objetivo glicêmico e tempo de insulina ativa. Assim, sempre que o paciente verificar a glicemia capilar e/ou contabilizar os carboidratos, ele insere na bomba essas informações e a bomba estima a quantidade de insulina necessária. A terapia com a BI assim com as outras terapias medicamentosas para o tratamento do diabetes são privativas da medicina, portanto apenas o profissional médico pode prescrever.

Considerada padrão ouro para o tratamento do diabetes, o sucesso no uso da BI tem como aliado fundamental o processo de educação, realizado por educadores em diabetes, ou seja, profissionais da área da saúde (enfermeiros, médicos, nutricionistas, psicólogos, educadores físicos, entre outros) capacitados em educação em diabetes.

A educação deve ser constante, porque faz parte do processo de mudança de comportamento como na implementação do tratamento e momentos de recaída. É importante que o educador ouça as dificuldades, medos e angústias, sem julgamentos. É importante, também, reconhecer qualquer mudança mesmo que mínima, oferecendo elogios que aumentem a motivação.

O papel do educador em bomba de insulina é capacitar o paciente e familiares para que eles sejam capazes de gerenciar o uso e manuseio da bomba. Por meio do processo de educação, o paciente e sua família aprendem como atuar em situações de hipoglicemia e hiperglicemia, reconhecer falhas com sets de infusão, realizar rodízio dos locais de aplicação e usar configurações na BI em situações especificas como: doença, férias, festas e mudança de rotina. Nem sempre esse processo é simples, já que cada indivíduo necessita de um tempo para iniciar e implementar mudanças, por isso é importante individualizar o processo.

Nos Estados Unidos e na Europa o educador em diabetes é uma profissão formal, porém, no Brasil o educador ainda não é reconhecido como profissão e existem poucos centros especializados em bomba de insulina. Assim, os profissionais da área da saúde podem ser certificados pelas empresas que comercializam as terapias de BI, a fim de desenvolver o papel de educador.

E mais, a médica especialista que acompanha a criança foi certeira ao narrar a peculiaridade do caso (fls. 38/40):

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 20/09/2023 às 18:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800481-37.2022.8.12.0037 e código zl1cb4vl.

Atualmente apresenta oscilações glicêmicas frequentes, necessitando de doses de insulina muito baixas, que só poderiam ser conseguida através de um equipamento com o sistema de infusão contínua de insulina. Apresenta episódios recorrentes de hipoglicemia, mesmo com diminuição de doses basais e de correção.

Como trata-se de criança pequena, que precisa retomar a vida escolar aos 4 anos , e para isso precisaria de um suporte de segurança para hipoglicemias como o sistema 780 G, que permite suspensão da infusão de insulina antes de apresentar hipoglicemias. O sistema também permitiria aos pais e cuidadores acompanhar a glicemia à distância pelo celular, e se dirigir a escola em caso de hipoglicemia ou hiperglicemia que possam colocar a vida do paciente em risco. Atualmente a mãe não está trabalhando e pode se dedicar integralmente ao tratamento do paciente, porém a mesma precisará retomar seu trabalho e para a segurança do paciente seria mais adequado o uso de sistema de infusão contínua de insulina.

Como é consenso mundial no tratamento de crianças de baixa idade com diabetes tipo1 optamos por fazer teste drive com sistema de infusão continua de insulina. O uso da bomba no caso do paciente permitiria ajustes mais precisos da dosagem de insulina, com doses individualizadas a cada horário, diminuindo risco de ocorrência de hipoglicemia noturna, além de facilitar a adesão ao tratamento e minimizar o risco de complicações agudas e crônicas do diabetes.

Vale ressaltar que o paciente mesmo sendo criança precisa medir a glicemia capilar, por perfuração nos dedos de 8 a 10 vezes por dia, e após cada aferição de glicemia, precisa de uma picada de correção com a insulina ultra-rápida. O uso da bomba além de permitir mais conforto para o paciente, menor risco de complicações e melhor controle glicêmico também trará o benefício na redução de picadas para a correção das glicemias (as picadas para troca do cateter da bomba são realizadas uma vez a cada 3 dias). Quanto aos critério de educação e conhecimento de contagem de carboidratos, necessários para que a família utilize adequadamente o equipamento , considero que os pais já estão treinados , passaram inclusive com nutricionista especializada em diabetes.

Diante disso indico tratamento para o paciente com bomba de insulina conforme receita em anexo. O uso da bomba irá melhorar a qualidade de vida do paciente, o controle do diabetes e evitar a ocorrência de complicações agudas e crônicas que coloquem em risco a vida da paciente.

Ademais, segundo se extrai dos excertos acima, a técnica em discussão não se trata de inovação, estando no mercado há vários anos, não havendo dúvidas, portanto, sobre sua **eficácia e confiabilidade.**

Outrossim, é indiscutível que a bomba de insulina é considerada uma órtese externa nos termos do artigo 10, VII, da Lei 9.656/98. Acontece que, em razão das peculiaridades da condição de saúde da criança e do que foi firmado no relatório médico de fls. 37/40, **é nítido que a bomba infusora de insulina não é apenas o tratamento mais indicado, e, sim, o único viável para o controle adequado da doença.**

Diante do exposto, sem sombra de dúvidas, **concluo que restaram preenchidos os requisitos** inseridos no artigo 10, §13, da Lei nº 9.656/98, pela Lei nº 14.454/2022, sendo a procedência medida que se impõe para o fim de condenar a requerida a fornecer o sistema de infusão de insulina para o autor.

Por decorrência lógica, se é devido o sistema de infusão de insulina na modalidade domiciliar, também devem ser fornecidos todos os insumos necessários, bem como o medicamento, por óbvio.

Acerca do tratamento domiciliar, recentemente o STJ fixou tese

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 20/09/2023 às 18:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800481-37.2022.8.12.0037 e código zl1cb4vl.

em consonância com o raciocínio acima efetuado:

> ***A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário - insumos a que ele faria jus caso estivesse internado no hospital -, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital.*** *STJ. 3ª Turma. REsp 2.017.759-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/2/2023 (Info 765).*

Sendo assim, **também são devidos o fornecimento dos insumos e do medicamento** receitados por médico especialista a fim de que o sistema de infusão de insulina possa permanecer exercendo sua função adequadamente.

Em arreamte, anoto que, em casos semelhantes, vem decidindo o TJMS:

> AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA A PACIENTE COM DIABETES – ROL DA ANS – LEI Nº 9.566/98, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.454/22 – REFERÊNCIA BÁSICA (ART. 10, § 12) – POSSIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL (ART. 10, § 13, II) – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em virtude da promulgação da Lei 14.454, de 21/09/2022, que alterou o art. 10 da Lei nº 9.566/98, o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, passou a constituir a referência básica para os planos privados de assistência à saúde, **devendo o tratamento prescrito por médico que não esteja no rol em questão ser autorizado quando preenchidos os requisitos constantes dos incisos I e II do § 13 do referido dispositivo, como no caso.** (**TJMS**. Agravo de Instrumento n. 1420542-78.2022.8.12.0000, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 04/02/2023, p: 07/02/2023)
>
> RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PACIENTE ACOMETIDO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 – PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA TRATAMENTO DA DOENÇA – BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO E DECLAROU CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO DE FORMA DEFINITIVA –

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 20/09/2023 às 18:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800481-37.2022.8.12.0037 e código zl1cb4vl.

> COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO POR BOMBA DE INSULINA – SENTENÇA EXEQUENDA QUE CONDICIONOU O TRATAMENTO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA – CUMPRIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. **A prescrição médica juntada aos autos ressaltou que o paciente necessita dos medicamentos/insumos pleiteados, sendo que a não utilização dos medicamentos/insumos ocasionará à parte autora descontrole dos níveis glicêmico, risco de cetoacidose e até o óbito, caso não faça uso do tratamento recomendado. Portanto, a necessidade do tratamento é indispensável para a manutenção e a qualidade de vida do requerente, sobretudo porque a doença não tem cura**. (**TJMS**. Apelação Cível n. 0805904-83.2022.8.12.0002, Dourados, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. João Maria Lós, j: 09/02/2023, p: 10/02/2023)

Por fim, em relação ao **dano moral,** dada a elevada controvérsia jurídica oriunda da alteração de posicionamento do STJ sobre a matéria, bem como da reversão legislativa operada pelo Congresso Nacional, concluo que, no caso vertente, a parte autora não faz jus à indenização pretendida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, julgo **parcialmente procedentes** os pedidos da inicial para o fim de **condenar** a parte requerida na obrigação de fazer consistente no fornecimento/disponibilização, no prazo de 15 (quinze) dias, do tratamento indicado nos relatórios médicos juntados à presente ação, qual seja: sistema de infusão contínua de insulina (bomba de insulina) - método da bomba Medtronic Minimed 780G[2] - e insumos[3]/medicamentos básicos mensais por todo o prazo que o tratamento se fizer necessário, na forma do relatório médico juntado (fls. 37/40), sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada, inicialmente, a 20 (vinte) dias.

Por consequência, necessário é **conceder**, neste momento, a liminar pleiteada pela parte autora (nos mesmos moldes acima estipulados), conforme já devidamente fundamentado às fls. 67/70 e neste julgamento, sendo que os efeitos passam a vigorar a partir da publicação desta sentença (art. 1.012, §1º, inciso V, do CPC).

Ante a sucumbência mínima da parte autora (art. 86, parágrafo único), **condeno** a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das

[2] Sendo confirmado que parte autora já adquiriu o dispositivo eletrônico, fica determinada, desde logo, a conversão em obrigação de pagar quantia a fim de reembolsar o demandante.
[3] Sendo confirmado que parte autora já adquiriu os insumos permanentes (os quais não são comprados mensalmente), fica determinada, desde logo, a conversão em obrigação de pagar quantia a fim de reembolsar o demandante.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 20/09/2023 às 18:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800481-37.2022.8.12.0037 e código zl1cb4vl.

custas processuais e demais despesas.

Também por decorrência do presente julgamento, imperiosos se tornam alguns ajustes quanto os valores devidos e reembolsáveis para cada uma das partes.

Suspendo <u>parcialmente</u> a determinação de fls. 338/339, que outrora impôs à parte autora o reembolso da quantia de fls. 285 em favor da parte requerida. Explico. Apesar de o dinheiro ter sido utilizado para aquisição de insumos (fl. 236) durante período no qual a liminar inicialmente concedida estava revogada (efeito *ex tunc*, conforme acórdão de fls. 314/320), é certo que a obrigação de fornecimento foi revivida com a presente sentença e a nova concessão da liminar.

Dessa sorte, dos itens adquiridos à fl. 236, aqueles considerados permanentes (ou seja, que são adquiridos somente uma vez, e não mensalmente), devem ser reembolsados à parte autora. Dito isso e considerando que são necessários esclarecimentos das partes sobre este ponto, **suspendo**, por ora, a ordem de expedição de alvará de levantamento (fl. 354) até que os litigantes prestem as informações necessárias através de petição interlocutória.

Deverá ser observado pela serventia deste juízo: (a) para a hipótese de interposição de recurso de apelação, intime-se o apelado para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, §1º); (b) havendo apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.010, §2º); (c) sendo suscitada(s) preliminar(es) nas contrarrazões, intime(m)-se o(s) recorrente(s) para, em 15 (quinze) dias, manifestar(em)-se (CPC, art. 1.009, §1º).

Atendidas as formalidades acima para a hipótese de interposição de recurso deste decisum, remetam-se os autos ao "juízo de segundo grau", com as homenagens de estilo, independentemente de nova conclusão.

Itaporã, 19 de setembro de 2023.

Evandro Endo
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 20/09/2023 às 18:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800481-37.2022.8.12.0037 e código zl1cb4vl.